

PREPARATION AU CONCOURS DE RESIDANAT

Module de Gastro-entérologie

Questions d'évaluation : Ulcère gastro-duodéal

1- L'ulcère gastroduodéal (UGD) est une maladie chronique récidivante définie anatomiquement par les critères suivants :

- A. Perte de substance pariétale ne dépassant pas la sous-muqueuse
- B. Présence de plexus nerveux hyperplasiques au niveau du socle scléro-inflammatoire
- C. Cicatrisation par ré-épithélialisation sur un bloc scléreux.
- D. Absence d'altération vasculaire.
- E. Siège préférentiellement en post bulbaire

2- Concernant l'ulcère bulbaire, les propositions vraies sont:

- A) Il est essentiellement favorisé par le tabagisme
- B) Il a une composante héréditaire
- C) Il est généralement due à une gastrite diffuse sévère
- D) Il peut être favorisé par une augmentation de la masse cellulaire pariétale
- E) Il peut être secondaire à une diminution du tonus vagal 70% des cas.

3- les deux principaux facteurs incriminés dans l'étiopathogénie de l'ulcère gastrique sont:

- A- L'hérédité.
- B- Le tabac.
- C- Le stress.
- C- La prise d'AINS ou d'aspirine.
- E- Infection par *Helicobacter pylori*.

4- concernant l'ulcère gastrique, les propositions vraies sont:

- A. Il est associé généralement à une sécrétion acide élevée.
- B. Il est favorisé par des altérations de la barrière muqueuse.
- C. Il est principalement dû à *Helicobacter pylori*.
- D. Il est plus nettement influencé par des facteurs psychoaffectifs que l'ulcère duodéal.
- E. Il est favorisé par une augmentation de la sensibilité des cellules pariétales à la gastrine.

5- Parmi les facteurs suivants, ceux qui peuvent favoriser le développement de la maladie ulcéreuse duodénale:

- A. L'augmentation de la sécrétion de bicarbonates
- B. La baisse de la sécrétion de la pepsine I
- C. Le tabac via une augmentation de la sensibilité des cellules pariétales gastriques
- D. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens par une augmentation du flux sanguin muqueux
- E. Le stress via une augmentation de la masse cellulaire pariétale

6- Parmi les facteurs étiopathogéniques de la maladie ulcéreuse gastro-duodénale, ceux qui sont favorisés par la prise des anti-inflammatoires non stéroïdiens :

- A. L'inhibition de la sécrétion de bicarbonates
- B. L'inhibition de la sécrétion du mucus
- C. L'inhibition de la rétrodiffusion des ions H^+
- D. L'augmentation de la sécrétion des prostaglandines
- E. L'augmentation de la sécrétion acide gastrique

7- L'hélicobacter pylori:

- A-Est une bactérie cocci gram négatif
- B-Colonise la muqueuse gastrique grâce à son activité uréasique
- C-Augmente la sécrétion acide gastrique via une inhibition de la secretion de gastrine
- D-peut être à l'origine d'une réaction inflammatoire locale par la production de prostaglandines
- E-Se caractérise par une transmission oro-fécale

8- Le pouvoir pathogène de l'hélicobacter pylori implique:

- A- Une diminution de la sécrétion acide basale
- B-Une inhibition de la cyclo-oxygénase
- C-Un effet cytotoxique direct
- D-Une hypogastrinémie
- E-Une réaction inflammatoire de la muqueuse gastrique

9. Concernant le syndrome ulcéreux typique, les propositions vraies sont:

- A. Il constitue le maître symptôme de la maladie ulcéreuse
- B. Les douleurs épigastriques sont typiquement à type de brûlure
- C. Les épigastralgies surviennent surtout en hiver
- D. La survenue de douleurs épigastriques réveillant le patient la première moitié de la nuit est très évocatrice
- E. Les épigastralgies surviennent généralement 2-3H après les repas

10. La douleur d'un syndrome ulcéreux a les caractéristiques suivantes :

- A- Calmée par les AINS.
- B- Améliorée par l'antéflexion.
- C- Survient à distance des repas.
- D- Evolue par poussées entrecoupées de périodes d'accalmie
- E- Calmée par les antiacides.

11. Chez un patient atteint d'un ulcère duodénal non compliqué:

- A- L'examen physique est souvent normal
- B- Les douleurs épigastriques sont typiquement perçues comme une crampe ou une torsion
- C- La douleur est permanente durant la journée
- D- La biopsie des berges de l'ulcère est systématique
- E- Un syndrome de Zollinger Ellison doit être suspecté en cas d'ulcères multiples

12. Pour le diagnostic de l'ulcère duodénal dans sa forme typique et non compliquée :

- A. Le tubage gastrique est d'un grand intérêt.
- B. Le TOGD doit être pratiqué en première intention.
- C. Les biopsies per-endoscopiques sont essentielles au niveau bulbaire.
- D. L'endoscopie est essentielle pour le diagnostic.
- E. L'endoscopie de contrôle est systématique après traitement.

13. Le diagnostic d'infection à *Helicobacter pylori* peut être fait par :

- A- La sérologie.
- B- Les hémocultures.
- C- Le test respiratoire à l'urée (breath test)
- D- La coproculture.
- E- L'histologie des biopsies gastriques

14. le test rapide à l'uréase:

- A. Représente l'examen le plus spécifique pour le diagnostic de l'infection à *Helicobacter pylori*
- B. Permet un diagnostic rapide de la bactérie
- C. Il consiste en la mise au contact du sérum avec de l'urée et un réactif
- D. Se fait en salle d'endoscopie
- E. Sa lecture nécessite au moins une heure

15. Concernant l'examen anatomopathologique des biopsies gastriques à la recherche de l'infection à *Helicobacter pylori*:

- A. Représente la méthode de référence pour le diagnostic positif
- B. Sa sensibilité et sa spécificité ne dépassent pas 90%
- C. Sa sensibilité est diminuée en cas de traitement par IPP
- D. Repose sur l'identification de la bactérie par la coloration de Perls
- E. Permet le typage de la souche bactérienne

16. Concernant la culture de l'*Helicobacter pylori*:

- A. C'est l'examen le plus fréquemment utilisé pour le diagnostic de l'infection
- B. Permet le typage de la souche bactérienne
- C. Permet l'étude de la résistance aux antibiotiques
- D. Sa spécificité est de 100%
- E. Représente la méthode de choix pour le contrôle d'éradication de la bactérie

17. Les biopsies faites au niveau d'un ulcère gastrique chronique :

- A. Peuvent mettre en évidence une néoplasie malgré un aspect macroscopique typique d'ulcère bénin.
- B. Permettent d'éliminer un cancer devant un aspect suspect à l'endoscopie.
- C. Doivent être réalisées à chaque examen endoscopique même si l'ulcère est cicatrisé
- D. Doivent être refaites 2 mois plus tard si l'ulcère n'a pas cicatrisé avec éradication de Hp.
- E. Doivent être faites au fond de l'ulcère

18. Le diagnostic de syndrome de Zollinger Ellison est systématiquement évoqué devant :

- A) une récurrence post opératoire d'un ulcère duodénal
- B) une maladie ulcéreuse duodénale résistance au traitement médical strictement observé
- C) une maladie ulcéreuse grave et récidivante
- D) une maladie ulcéreuse avec une diarrhée chronique
- E) Un débit acide basal est diminué au tubage gastrique.

19. Le syndrome de Zollinger Ellison:

- A- Peut être secondaire à une tumeur bénigne de paroi duodénale
- B- Peut être due à une tumeur maligne du pancréas endocrine
- C- Doit être évoqué devant l'association d'un ulcère bulbaire à une diarrhée aiguë
- D- Doit être évoqué devant un ulcère résistant au traitement médical bien conduit
- E- Est secondaire à une tumeur est souvent mise en évidence par l'imagerie en coupe

20. Concernant la maladie ulcéreuse gastro-duodénale chez l'enfant:

- A- Elle est rare
- B- La localisation duodénale est 7 fois plus fréquente que la localisation gastrique
- C- L'ulcère gastrique s'observe souvent après 7 ans
- D- L'ulcère duodénal est surtout favorisé par la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens
- E- En cas d'ulcère gastrique, des antécédents d'ulcère surtout chez le père sont notés dans 60% des cas

21-L'ulcère gastrique:

- A-Est le plus souvent multiple
- B- Est souvent secondaire à une sécrétion acide gastrique élevée
- C-Impose la pratique des biopsies pour confirmer sa bénignité
- D-Siège souvent au niveau de l'angle de la petite courbure gastrique
- E-Est souvent associé à une métaplasie gastrique

22. Le score de Glasgow-Blatchford comprend les paramètres Suivants:

- A. Le pouls
- B. La Tension artérielles diastolique
- C. Le taux d'hémoglobine
- D. Les besoins transfusionnels
- E. La créatinine

23. Au cours de l'ulcère gastro-duodéal hémorragique, le stade IIa de la classification de Forrest correspond à:

- A. Un saignement en nappe
- B. Un Vaisseau visible non hémorragique
- C. Des taches de fibrines noires
- D. Un saignement en jet
- E. Un caillot adhérent

24. les facteurs de risque de récurrence de l'hémorragie ulcéreuse gastro-duodénale sont:

- A. L'âge > 50 ans
- B. La localisation de l'ulcère au niveau de la face postérieure du bulbe
- C. La localisation de l'ulcère au niveau de la grande courbure gastrique
- D. La présence d'une hémorragie en nappe à l'endoscopie
- E. La grande taille de l'ulcère (>2cm)

25. Dans la sténose pyloro-duodénale d'origine ulcéreuse, on peut observer :

- A- Des vomissements alimentaires
- B- Une masse épigastrique palpable
- C- Un clapotage à jeun
- D- Un silence à l'auscultation de l'abdomen à un stade précoce
- E- Un pli cutané persistant

26. Concernant la sténose ulcéreuse Gastro-duodénale:

- A- Les ulcères gastriques exposant plus à cette complication que les ulcères duodénaux
- B- L'hypokaliémie est souvent due aux échanges rénaux des ions H^+ contre les ions K^+ pour lutter contre l'alcalose
- C- Les vomissements sont typiquement postprandiaux précoces
- D- Le transit oeso-gastro-duodénal peut être utile pour le diagnostic positif
- E- Le scanner abdominal pourrait être utile pour éliminer une sténose tumorale

27. L'ulcère bulbaire peut se compliquer de :

- A- Hémorragie digestive
- B- Ictère obstructif.
- C- Perforation.
- D- Adénocarcinome
- E- Fistulisation dans les voies biliaires

28. Au cours de la péritonite par perforation d'ulcère duodénal:

- A- La douleur initiale est de siège sous-ombilical.
- B- La douleur débute brutalement.
- C- Il existe d'emblée une fièvre élevée.
- D- Il existe une douleur au cul-de-sac de Douglas au toucher rectal.
- E- La douleur reste localisée à l'épigastre.

29. les conseils hygiéno-diététiques dans le traitement de l'ulcère duodénal sont:

- A. Interdire les aliments épicés.
- B. Limiter les apports de café.
- C. Eviter la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens.
- D. Arrêter le tabac
- E. Conseiller un régime lacté

30. Les effets de l'omeprazole au cours de la maladie ulcéreuse gastro-duodénale:

- A- Il optimise l'action des antibiotiques
- B- Il diminue la sécrétion acide de l'estomac par inhibition de la pompe à protons.
- C- Il entraîne une vasodilatation des vaisseaux gastriques.
- D- Il stimule la motricité antrale.
- E- Il accroît la sécrétion de mucus protecteur de la muqueuse gastrique.

31. Devant un ulcère duodénal non compliqué, le traitement de l'éradication de l'*Helicobacter pylori* proposé en première intention comporte :

- A. Un IPP double dose + 2 antibiotiques pendant 7 jours.
- B. Un IPP double dose + 3 antibiotiques pendant 14 jours.
- C. une association de 3 antibiotiques pendant 7 jours.
- D. Un antisécrétoire type anti-H2 + 2 antibiotiques pendant 10 jours.
- E. Un IPP simple dose + 2 antibiotiques pendant 10 jours.

32. Les médicaments antibactériens utilisés, en première intention, dans le traitement d'un ulcère duodénal associé à l'infection par *Helicobacter pylori* sont :

- A. Le céfotaxime
- B. L'amoxicilline
- C. Le métronidazole
- D. L'azithromycine
- E. La tetracycline

33. Les médicaments antibactériens pouvant être utilisés dans le traitement d'un ulcère duodénal associé à l'infection par *Helicobacter pylori* sont :

- A. L'ofloxacine
- B. La Lévofloxacine
- C. Le métronidazole
- D. La tétracycline
- E. La Ciprofloxacine

34. La quadrithérapie bismuthée associe les molécules suivantes:

- A- Esoméprazole
- B- Tétracycline
- C- Clarithromycine
- D- Méttronidazole
- E- Lévofloxacine

35. La durée du traitement par quadrithérapie bismuthée est de:

- A. 14 jours
- B. 10 jours
- C. 7 jours
- D. 15 jours
- E. 8 jours

36. concernant la prise en charge de l'ulcère duodénal non compliqué:

- A) Une nouvelle endoscopie 2 mois plus tard n'est pas indispensable
- B) La prise d'AINS peut être autorisée
- C) Le traitement d'éradication de *l'Helicobacter pylori* diminue le taux de récurrence
- D) Un traitement de consolidation par un IPP à simple dose est indiqué en cas de traitement par anticoagulant
- E) Le tabagisme peut être repris après cicatrisation de l'ulcère

37. Après le traitement d'un ulcère duodénal non compliqué:

- A- La pratique d'une fibroscopie oesogastro-duodénale est systématique pour le contrôle de la cicatrisation
- B- Le contrôle d'éradication de HP est obligatoire
- C- Les biopsies pour éliminer un cancer sont systématiques
- D- L'éradication de HP se fait dans plus de 90% des cas après traitement de 1^{ère} ligne
- E- Le traitement d'entretien est toujours indiqué pendant 6-8 semaines

38. Chez un patient atteint d'un ulcère gastrique:

- A- Le traitement d'éradication de l'Hélicobacter pylori est systématique
- B- Le traitement de consolidation par IPP monodose est obligatoire
- C- La fibroscopie de contrôle est systématique à la fin de traitement
- D- Le contrôle de l'éradication l'Hélicobacter pylori n'est pas obligatoire
- E- La chirurgie est indiquée en l'absence d'éradication d'Hélicobacter pylori après deux cures complètes

39. Le traitement chirurgical en cas d'UGD doit être proposé d'emblée en cas de :

- A- Hémorragie digestive cataclysmique
- B- Ulcère perforé.
- C- Ulcère gastrique avec persistance de l'infection à HP
- D- Ulcère gastrique chez un malade tabagique et sous AINS au long cours.
- E- Sténose bulbaire inflammatoire

40. Un traitement de consolidation systématique par les inhibiteurs de la pompe à protons est indiqué en cas de :

- A. Ulcère duodénal non compliqué chez un patient sous clopidogrel
- B. Ulcère gastrique non compliqué
- C. Ulcère duodénal compliqué d'hémorragie
- D. Ulcère duodénal non compliqué chez un patient traité par les anti-inflammatoires non stéroïdiens
- E. Ulcère gastrique compliqué

41. Parmi les médicaments suivants, ceux qui peuvent favoriser la survenue d'une hémorragie digestive chez un malade ayant un ulcère duodénal:

- A- Sintrom.
- B- Digoxine.
- C- Aspirine.
- D- Gentamycine.
- E- Anti-inflammatoires non stéroïdiens.

Cas clinique 1

Patient M. H. âgé de 50 ans, vous consulte pour douleurs épigastriques intenses de survenue brutale évoluant depuis 3 heures sans aucune autre plainte associée.

* Dans ses antécédents on note :

- Tabagisme chronique non sevré (50 PA).
- Alcoolisme non sevré (50g/j depuis 10 ans).
- ACFA sous aspirine depuis 6 ans.
- Ulcère duodénal il y a 10 ans traité médicalement.
- Arthrose des 2 genoux suivie en rhumatologie sous antalgiques type paracétamol.

L'examen physique a révélé un patient apyrétique avec une défense au niveau de l'épigastre

Vous évoquez chez ce patient le diagnostic d'un ulcère perforé

1. A ce stade, en plus du diagnostic d'ulcère perforé, les autres diagnostics à évoquer chez ce patient sont:

- A. Crise hyperalgique d'ulcère
- B. IDM antéro-septal
- C. Une pancréatite aiguë
- D. Un infarctus mésentérique
- E. Une colique intestinale

2. A ce stade, l'examen paraclinique que vous devez demander en premier est:

- A. Une fibroscopie oeso-gastro-duodénale
- B. Une transit oeso-gastro-duodénal
- C. Un abdomen sans préparation debout
- D. Une radiographie du thorax centrée sur les coupes diaphragmatiques
- E. Un coroscanner

Les explorations paracliniques réalisées chez ce patient ont conclu à un ulcère duodénal perforé

3. La prise en charge thérapeutique que vous allez proposer pour ce patient consiste en:

- A. La prescription d'une cure d'éradication de l'*Hélicobacter pylori* dans les 24H
- B. Une suture de la perforation duodénale
- C. La pose d'un clip métallique par voie endoscopique
- D. Une toilette péritonéale avec prélèvement bactériologique
- E. La réalisation d'une gastro-entéro anastomose

Cas clinique 2

Un patient âgé de 46 ans, tabagique, consulte pour des douleurs épigastriques sans irradiation, évoluant depuis trois mois, à type crampes, rythmées par les repas, et calmées par les anti-sécrétoires. L'examen clinique est sans anomalies.

Le diagnostic d'ulcère gastro-duodénal a été évoqué .

1. L'examen complémentaire que vous allez demander pour confirmer le diagnostic d'ulcère gastrique ou duodénal est:

- A- Une échographie abdominale
- B- Une fibroscopie digestive haute
- C- Un entéroscanner
- D- Une sérologie de l'*helicobacter pylori*
- E- Une EntéroIRM

2. Cet examen a été réalisé objectivant une perte de substance ovalaire de 1 cm de la face postérieure du bulbe , les complications possibles de cet ulcère sont:

- A- La perforation en péritoine libre
- B- Le cancer duodénal
- C- Fistule cholédoco-gastrique
- D- L'hémorragie digestive
- E- La sténose digestive haute

3. Les traitement(s) que vous préconisez chez ce malade en première ligne sont:

- A-IPP double dose pendant 14j
- B-IPP double dose + amoxicilline + clarithromycine+ metronidazole pendant 14j
- C-IPP double dose + levofloxacin + amoxicilline pendant 10j
- D-IPP double dose + Pylera pendant 10j
- E-Chirurgie

Ce patient a été perdu de vue pendant 5 ans et n'a pas pris son traitement prescrit ,Il consulte les urgences pour persistance des épigastalgies avec des vomissements alimentaires post prandiaux tardifs évoluant depuis 1 mois. L'examen a mis en évidence des signes de déshydratation, A la biologie: kaliémie:2,9mmol/l, urée:9mmol/l, créatinine: 110μmol/l

4. une sténose ulcéreuse du bulbe a été suspectée, Afin de confirmer ce diagnostic vous allez demander:

- A- Un transit oeso-gastro-duodénal
- B- Une Fibroscopie oeso-gastro-duodénale
- C- Un enteroscanner
- D- Une coelioscopie diagnostique
- E- Une vidéocapsule

5. Le diagnostic d'ulcère bulbaire compliqué de sténose a été confirmé ,la prise en charge thérapeutique que vous allez proposer sera:(une ou plusieurs propositions juste)

- A- Une mise au repos du tube digestif
- B- Correction des désordres hydroélectrolytiques
- C- Chirurgie : Excision de l'ulcère
- D- Inhibiteurs de la pompe à protons par voie intra veineuse
- E- Une dilatation endoscopique d'emblée